

3.3.17. Elosulfase alfa (如 Vimizim) (107/4/1、112/7/1)

1. 診斷：除了臨床表徵及尿液葡萄糖胺聚糖定性、定量檢驗的佐證外，須證明患者之週邊血液白血球或經培養之皮膚纖維芽細胞 GALNS 活性缺乏，或是患者 GALNS 基因經分子生物學檢驗確認有兩個分別來自父母雙方，已知或必然會引起黏多醣症第 IVA 型之突變。
2. 限小兒遺傳專科醫師使用。
3. 排除使用於：
 - (1) 患者合併有其他嚴重疾病，無法從酵素治療得到長期效益。
 - (2) 重型病患：完全臥床且無行動能力，或是無法自行呼吸且完全仰賴呼吸器維生者。
 - (3) 病患不願意配合追蹤評估。
4. 黏多醣症第四型患者之傷害多屬不可逆性，治療前應與患者及家屬充分溝通告知下列事項，並請其簽名確認已被告知，留存病歷備查：
 - (1) 確定其了解治療的預期效果。
 - (2) 患者有義務接受定期追蹤評估。
5. 需經事前審查核准後使用，每次申請之療程以 1 年為限。重新申請時，依下列病患疾病進程分類，若有評估項目中任兩項未達標準，則不予同意使用：
 - (1) 5 歲以上至少能以助行器行走的患者，針對下列 I. ~ V. 項。
(112/7/1)
 - (2) 5 歲以上無法行走的患者，針對下列 II. ~V. 項。(112/7/1)
 - (3) 未滿 5 歲的患者，針對下列 III. ~V. 項。(112/7/1)
 - I. 6 分鐘步行測驗：相較於治療前，至少有 10% 的改善，或在達療效高原期後維持 10% 的改善。
 - II. 呼吸功能檢查：FVC 或 FEV-1 相較於治療前至少有 5% 的改善，或在達療效高原期後維持 5% 的改善。
 - III. 尿液中 keratan sulfate (Uks) 相較於治療前降低大於 20%。

IV. 呼吸功能檢查：血液中氧氣飽和度(SpO_2)在 2 小時內需持續維持 1 小時以上 $\geq 90\%$ 。

V. 以心臟超音波檢測，Ejection Fraction 維持在正常範圍內 (Ejection Fraction $\geq 50\%$)。(112/7/1)

6. 須立即停止 elosulfase alfa 治療的情形：

(1)病人在接受治療時發生其它致命的疾病，這表示病人無法獲得 elosulfase alfa 的療效。

(2)病患發生嚴重不良反應。

(3)病患無法配合最適療程所需的注射規定或無法配合療效的評估。